



Douleur scrotale

Par [Geetha Maddukuri](#), MD, Saint Louis University
Reviewed By [Leonard G. Gomella](#), MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Vérifié/Révisé sept. 2024

Une douleur scrotale peut se produire chez l'homme à tout âge, du nouveau-né aux hommes âgés.

Étiologie de la douleur scrotale

Les **causes les plus fréquentes** de douleurs scrotales sont les suivantes

- [Torsion testiculaire](#)
- Torsion des annexes testiculaires
- [Épididymite/épididymo-orchite](#)

Il existe un certain nombre de causes moins fréquentes (voir tableau [Certaines causes de douleurs scrotales](#)). L'âge, le début des symptômes et d'autres signes peuvent permettre de déterminer la cause.

TABLEAU		
Certaines causes de douleurs scrotales		
Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique
Torsion testiculaire	Apparition soudaine de douleur sévère, unilatérale, constante Réflexe crémastérien absent Asymétrique transversalement orientés, testicule élevé du côté atteint Apparaît typiquement chez le nouveau-né et les garçons post-pubertaires	Échodoppler couleur

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique
	mais peut être observé chez l'adulte	
Torsion d'un hydatide (une structure vésiculaire non pédonculée attachée au pôle céphalique du testicule)	Apparition subaiguë de la douleur en quelques jours Douleur dans le pôle supérieur du testicule Réflexe crémastérien présent Peut exister une hydrocèle réactive, signe du point bleu (point bleu ou noir sous la peau sur le côté supérieur des testicules ou de l'épididyme) Survient typiquement chez les garçons âgés de 7 à 14 ans	Échodoppler couleur
Épididymite ou orchi-épididymite, habituellement infectieuses, à microorganismes Gram négatifs chez le garçon prépubère et chez l'homme âgé ou, chez l'homme sexuellement actif, infections sexuellement transmissibles Peuvent être non infectieuses, résultant d'un reflux d'urine dans les canaux éjaculateurs	Début de la douleur aigu ou subaigu dans l'épididyme et également parfois dans les testicules Possible pollakiurie, dysurie, récentes préhension ou efforts Réflexe crémastérien présent Souvent induration, tuméfaction, érythème scrotaux Parfois, écoulement du pénis Apparaît typiquement chez les garçons post-pubères et chez l'homme	ECBU Techniques d'amplification des acides nucléiques pour <i>Neisseria gonorrhoeae</i> et <i>Chlamydia trachomatis</i>

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique
Post-vasectomie, les cas aigus et chroniques (syndrome de douleur post-vasectomie)	Anamnèse de vasectomie Douleur pendant les rapports et/ou l'éjaculation Douleur pendant l'exercice physique Épididyme sensible ou plein	Bilan clinique
Traumatisme	Antécédent certain d'un traumatisme des organes génitaux Souvent augmentation de volume, possible hématome intratesticulaire ou hématocèle	Échodoppler couleur
Hernie inguinale (étranglée)	En général, antécédent de tuméfaction non douloureuse (souvent un diagnostic connu de hernie) avec une douleur aiguë ou subaiguë Masse scrotale, habituellement grande, compressible, éventuellement avec des bruits intestinaux audibles Non réductible	Bilan clinique
Vascularite à immunoglobulines A (purpura Henoch-Schönlein)	Purpura palpable (classiquement des membres inférieurs et des fesses), arthralgie, arthrite, douleurs abdominales, néphropathie Apparaît typiquement chez les garçons âgés de	Bilan clinique Parfois, biopsie des lésions cutanées

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique
Polyartérite noueuse	3–15 ans	
	Fièvre, perte de poids, douleur abdominale, HTA, œdème Lésions cutanées dont le purpura palpable et les nodules cutanés Peut être aiguë ou chronique Peut provoquer une ischémie et un infarctus du testicule Plus fréquente chez l'homme de 40–50 ans	Angiographie Parfois, biopsie des organes atteints
Douleur projetée (anévrisme de l'aorte abdominale , lithiase urinaire , pincement de la racine nerveuse inférieure lombaire ou sacrée, appendicite rétro-caecale, tumeur rétropéritonéale, douleurs post-herniorraphie)	Examen scrotal normal Parfois, douleur abdominale selon la cause	Selon les signes d'examen clinique et la cause suspectée
Orchite (habituellement virale, p. ex., oreillons; rubéole; virus coxsackie, échovirus ou parvovirus)	Douleur scrotale et abdominale, nausées, fièvre Tuméfaction unilatérale ou bilatérale, érythème du scrotum	Charges virales à la phase aiguë et convalescente
Gangrène de Fournier (fasciite nécrosante du périnée)	Douleur sévère, fièvre, manifestations toxiques, érythème, vésication ou lésions nécrotiques Parfois, gaz sous-cutanés palpables	Bilan clinique

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique
	Parfois, antécédent de chirurgie abdominale récente	
	Plus fréquente chez l'homme âgé diabétique et/ou souffrant d'une maladie vasculaire périphérique	

Évaluation d'une douleur scrotale

Une évaluation, un diagnostic et un traitement rapide sont nécessaires parce qu'une [torsion testiculaire](#) non traitée peut entraîner une perte d'un testicule.

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit déterminer l'emplacement (unilatérale ou bilatérale), le début (aigu ou subaigu), et la durée de la douleur. Les symptômes associés significatifs comprennent une fièvre, une dysurie, un écoulement urétral et la présence de masse scrotale. Il faut interroger les patients sur les événements précédents, dont une lésion, des efforts ou un effort et un rapport sexuel.

La **revue des systèmes** doit chercher les symptômes responsables du trouble, dont une éruption purpurique, une douleur abdominale et des arthralgies (une [vascularite à immunoglobulines A](#) [purpura de Henoch-Schönlein]); des masses scrotales intermittentes et/ou une augmentation de volume de l'aine (hernie inguinale); une fièvre et un gonflement de la parotide (orchite ourlienne); une douleur de l'hypochondre ou une hématurie ([calculs rénaux](#)).

La **recherche des antécédents médicaux** doit permettre d'identifier les troubles connus qui peuvent provoquer une douleur projetée, dont des hernies, l'[anévrisme de l'aorte abdominale](#), les calculs rénaux et les facteurs de risque de contracter des pathologies sévères, dont le diabète et les maladies vasculaires périphériques (gangrène de Fournier).

Examen clinique

L'examen clinique commence par une revue des fonctions vitales et l'évaluation de la gravité de la douleur. L'examen se concentre sur l'abdomen, la région inguinale et les organes génitaux.

L'abdomen est examiné à la recherche d'une sensibilité et d'autres masses (dont une dilatation vésicale). Les hypochondres sont percutés afin de détecter une sensibilité des fosses lombaires.

L'examen inguinal et génital doit être pratiqué en position debout. La région inguinale est inspectée et palpée à la recherche d'une adénopathie, d'une tuméfaction ou d'un érythème. L'examen du pénis doit avoir pour but de noter les ulcérations, l'écoulement urétral et les piercings et tatouages (sources d'infections bactériennes). L'examen scrotal vise à noter toute asymétrie, tuméfaction, érythème ou anomalie de coloration et de position des testicules (horizontale versus verticale, élevée versus basse). Le réflexe crémasterien doit être testé bilatéralement. Les testicules, les épидидymes et les cordes spermatiques doivent être palpés pour détecter un œdème et une sensibilité. Devant une grosse bourse, la transillumination permet de différencier une hydrocèle d'une tumeur solide.

Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Apparition soudaine d'une douleur; une douleur exquise; et des testicules élevés à l'horizontale (une [torsion testiculaire](#))
- Masse inguinale ou scrotale non réductible provoquant des douleurs, des vomissements et une constipation (une hernie étranglée)
- Érythème scrotal ou périnéal, lésions cutanées nécrotiques ou avec bulles et manifestations toxiques (gangrène de Fournier)
- Apparition brutale de douleur, hypotension, pouls faible, pâleur, vertige et confusion (anévrisme rompu de l'aorte abdominale)

Interprétation des signes

L'objectif est de distinguer les causes qui doivent être traitées immédiatement des autres. Les signes cliniques fournissent des indices importants (voir tableau [Certaines causes de douleurs scrotales](#)).

Les catastrophes aortiques et la gangrène de Fournier surviennent principalement chez les patients âgés de > 50 ans; les autres affections qui doivent être traitées immédiatement peuvent survenir à tout âge. Cependant, une torsion testiculaire est très fréquente chez le nouveau-né et les garçons post-pubères, une torsion des annexes testiculaires survient le plus souvent chez les garçons prépubères (7 à 14 ans) et une [épididymite](#) est très fréquente chez les adolescents et les adultes.

Une apparition brutale sévère d'une douleur suggère une torsion testiculaire ou des [calculs rénaux](#). Une douleur épидидymaire, une hernie étranglée ou une [appendicite](#) est davantage à début progressif. En cas de torsion des annexes testiculaires, les patients présentent des douleurs modérées qui se développent sur quelques jours; la douleur est localisée au pôle supérieur. Une douleur bilatérale suggère une infection (p. ex., orchite, en particulier si elle est accompagnée d'une fièvre et de symptômes viraux) ou une cause rapportée. Des douleurs de l'hypochondre qui irradient au scrotum suggèrent des calculs rénaux ou, chez l'homme de > 55 ans, un anévrisme de l'aorte abdominale.

Un examen normal du scrotum et du périnée suggère une douleur projetée. Une attention doit alors être portée aux troubles extrascrotaux, en particulier l'appendicite, les calculs rénaux, et, chez l'homme de > 55 ans, l'[anévrisme de l'aorte abdominale](#).

Les signes à l'examen du scrotum et du périnée évoquent souvent une cause. Parfois, dans l'épididymite précoce, une sensibilité et une induration peut être localisée à l'épididyme; dans la torsion

initiale, les testicules peuvent être hauts, avec une position horizontale et aucun épидидyme particulièrement douloureux. Cependant, le testicule et l'épididyme sont souvent tous deux tuméfiés et douloureux, il existe un œdème scrotal et il n'est pas possible de distinguer une épидидymite d'une torsion par la palpation. Cependant, le réflexe crémasterien est absent dans la torsion, comme le sont les signes d'une [infection sexuellement transmissible](#) (p. ex., écoulement urétral purulent); la présence de ces deux signes évoque probablement une épидидymite.

Parfois, une masse scrotale provoquée par une hernie peut être palpée dans le canal inguinal; dans d'autres cas, la hernie peut être difficile à distinguer d'un gonflement testiculaire.

Un érythème douloureux du scrotum sans sensibilité des testicules ou des épидидymes doivent faire suspecter une infection, ou une [cellulite](#) ou une gangrène de Fournier précoce.

Un exanthème rénovasculaire, une douleur abdominale et des arthralgies sont compatibles avec une vascularite systémique telle que la [vascularite à immunoglobulines A](#) ou une [polyartérite noueuse](#).

Examens complémentaires

Un test est généralement effectué.

- ECBU (chez tous les patients)
- Tests des infections sexuellement transmissibles (tous les patients qui présentent un examen d'urines positif, un écoulement ou une dysurie)
- Échodoppler couleur pour éliminer une torsion (aucune cause alternative évidente)
- Autres tests selon les résultats (voir tableau [Certaines causes de douleurs scrotales](#))

Un ECBU des urines est toujours nécessaire. Les signes d'infection des voies urinaires (p. ex., pyurie, bactériurie) suggèrent une épидидymite. Les patients qui présentent des symptômes évoquant une infection urinaire et les patients qui présentent un écoulement urétral ou une [dysurie](#) doivent être testés pour rechercher les infections sexuellement transmissibles ainsi que d'autres causes d'infection urinaire bactérienne.

Un diagnostic opportun de torsion testiculaire est capital. Si les symptômes sont très évocateurs de torsion, une exploration chirurgicale immédiate est effectuée de préférence par rapport aux tests. Si les symptômes sont équivoques et qu'il n'existe aucune cause alternative claire d'une douleur scrotale aiguë, un [échodoppler couleur](#) est effectué. Lorsque l'échodoppler n'est pas disponible, une [scintigraphie](#) peut être effectuée mais est moins sensible et spécifique.

Traitement de la douleur scrotale

Le traitement est dirigé contre la cause et peut aller d'une intervention d'urgence ([torsion testiculaire](#)) à un alitement (torsion des annexes testiculaires). En cas de torsion testiculaire, une intervention chirurgicale rapide (< dans les 12 heures suivant la présentation) est généralement nécessaire. Une intervention chirurgicale tardive peut conduire à un infarctus testiculaire, à des lésions testiculaires à long terme ou à la perte d'un testicule. Une détorsion testiculaire soulage la douleur immédiatement et une orchidopexie simultanée bilatérale empêche la récurrence de torsion.

Les antalgiques, tels que la morphine ou d'autres opioïdes, sont indiqués dans le soulagement de la douleur aiguë. Les antibiotiques sont indiqués dans les [épididymites](#) ou les [orchites](#) bactériennes.

Bases de gériatrie: douleur scrotale

La torsion testiculaire est rare chez l'homme âgé et lorsqu'elle est présente, les manifestations sont habituellement atypiques avec le risque d'un diagnostic retardé. Une épididymite, une orchite et un traumatisme sont plus fréquents chez l'homme âgé. Parfois, une [hernie inguinale](#), une [perforation intestinale](#) ou des coliques néphrétiques peuvent provoquer une douleur scrotale chez l'homme âgé.

Points clés

- Toujours évoquer une torsion testiculaire en cas de douleurs scrotales, en particulier chez l'enfant et l'adolescent; un diagnostic rapide et précis est essentiel.
- Les autres causes fréquentes de douleur scrotale sont la torsion des annexes testiculaires et une épididymite.
- Un échodoppler couleur est habituellement effectué lorsque le diagnostic est incertain.
- Un examen normal du scrotum et du périnée suggère une douleur projetée.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.